

1. Revue de la littérature

1.1 Théories des transferts de migrants

La littérature identifie six familles de motivations à transférer, aux prédictions empiriques distinctes. Le modèle altruiste (Lucas et Stark, 1985) postule que le migrant intègre le bien-être du ménage d'origine dans sa fonction d'utilité : les transferts croissent avec le revenu du migrant et diminuent avec celui du receveur. Le modèle de l'intérêt personnel (self-interest) y oppose un migrant-investisseur qui protège ses droits patrimoniaux (héritage, terre) et sa position sociale ; le test expérimental d'Antoniades et al. (2013, jeu du dictateur auprès de migrants indiens au Qatar) montre que les deux mobiles coexistent selon l'histoire financière du migrant. La nouvelle économie des migrations (NELM, Stark et Bloom, 1985) fait du ménage l'unité de décision : la migration diversifie le portefeuille de revenus face aux défaillances des marchés du crédit et de l'assurance. Trois mobiles complémentaires s'y ajoutent : l'échange et le remboursement de dette implicite (Rapoport et Docquier, 2006), l'assurance contre les chocs, validée au Mali par Gubert (2002) et au Sénégal par Fall (2010), et l'investissement collectif des associations de ressortissants dans les infrastructures communautaires (Azam et al., 2016).

1.2 Canaux d'impact sur les enfants

Six canaux relient les transferts à la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Deux relèvent de l'investissement en capital humain : l'éducation (levée de la contrainte de liquidité, réduction du travail des enfants) et la santé/nutrition (consultations, vaccination, diversité alimentaire). Trois passent par l'habitat : accès à l'eau, assainissement, qualité du logement ; ces canaux sont plus lents car ils exigent des investissements indivisibles et une offre locale. Le canal collectif des associations de migrants peut en outre bénéficier aux ménages non récipiendaires.

1.3 Résultats empiriques et lacunes

Les études crédibles corrigent toutes l'endogénéité du statut de bénéficiaire (variables instrumentales, traitement endogène, appariement). Les effets documentés sont globalement favorables sur la scolarisation (Edwards Cox et Ureta, 2003 ; Yang, 2008 ; Gyimah-Brempong et Asiedu, 2013) et la santé infantile (Hildebrandt et McKenzie, 2005 ; Millogo et al., 2024 au Burkina Faso), mais systématiquement hétérogènes selon le genre, le milieu et la richesse (Bucheli et al., 2018), et contrebalancés par les coûts psychosociaux de l'absence parentale (Cortés, 2007, UNICEF ; Mansuri, 2006 ; Davis et Brazil, 2016). Trois lacunes motivent le mémoire : la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct d'analyse ; très peu de travaux portent sur le Sénégal ; la combinaison PSM-double différence sur panel n'y a jamais été appliquée.

2. Données

Le mémoire mobilise les deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages : EHCVM I (2018-2019, 7 156 ménages) et EHCVM II (2021-2022). La variable PanelHH identifie les 6 127 ménages suivis entre les deux vagues (taux de suivi de 85,6 %), formant un

panel vrai où les mêmes unités sont observées avant et après. L'échantillon d'analyse est constitué des enfants de 0 à 17 ans de ces ménages.

Le traitement est le statut stable de bénéficiaire de transferts internationaux : un ménage est traité s'il a reçu un transfert d'un expéditeur situé hors du Sénégal aux deux vagues, témoin s'il n'en a reçu à aucune des deux. Sur les 6 127 ménages du panel, on compte 681 traités stables, 3 981 jamais traités et 1 465 ménages au statut changeant (switchers), exclus de l'analyse causale conformément à Callaway et Sant'Anna (2021). Les transferts internes sont exclus car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte. Aucune pondération d'enquête n'est utilisée ; les erreurs-types sont clusterisées au niveau de la grappe.

3. Méthodologie

3.1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle

Deux mesures complémentaires sont construites. L'approche principale est le N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis), méthodologie officielle ANSD/UNICEF (2024) : sept dimensions (assainissement, eau, logement, nutrition, santé, protection de l'enfant, éducation), indicateurs différenciés par groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans), approche union à l'intérieur de chaque dimension, et seuil $k = 4$ dimensions sur 7 pour être multidimensionnellement pauvre. Référence nationale 2018 : $H = 50,7 \%$, $A = 72,2 \%$, $MO = 0,366$. En robustesse, un indice Alkire-Foster (2011) à 6 indicateurs équipondérés (éducation, santé, niveau de vie) avec seuil $k = 1/3$ fournit l'incidence H , l'intensité A et l'indice ajusté $MO = H \times A$.

3.2 Stratégie d'identification : PSM et double différence

La difficulté centrale est le biais de sélection : les ménages bénéficiaires diffèrent des autres sur des caractéristiques observables et inobservables. La stratégie combine deux méthodes (Heckman, Ichimura et Todd, 1997, 1998).

Première étape, l'appariement par score de propension au niveau ménage : un probit estime la probabilité de recevoir des transferts en fonction des caractéristiques de 2018 (taille du ménage, log de la dépense par tête, milieu, région, sexe, âge, éducation et statut matrimonial du chef). L'appariement principal est un k plus proches voisins ($k = 4$, avec remise) sur support commun ; le noyau d'Epanechnikov ($h = 0,06$) et le caliper (0,05, sans remise) servent de tests de robustesse. La qualité de l'appariement est vérifiée par les différences standardisées avant/après.

Seconde étape, la double différence sur le panel apparié : la variation de la pauvreté des enfants des ménages traités entre 2018 et 2021 est comparée à celle des témoins appariés, par la régression $Y = a + b \cdot t + c \cdot D + d \cdot (t \times D)$, pondérée par les poids d'appariement et avec erreurs-types clusterisées par grappe. Le coefficient d est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT). Le

PSM corrige la sélection sur les observables ; la DD élimine les effets fixes inobservables stables dans le temps.

La validité est éprouvée par une batterie de tests : sensibilité au seuil k et à la méthode d'appariement, test placebo (200 assignations aléatoires d'un faux traitement parmi les ménages jamais traités), analyse de l'attrition différentielle du panel, et hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe, groupe d'âge et dimension de privation.